

47%),第 2 组 164 例 (53%),第 2 组病例平均年龄高于第 1 组,但性别、血压、病史以及其它指标无差异。

2. 入选条件:须同时满足以下 3 项:①入选前至少 12 个月内有持续或间歇性心房颤动 (心电图证据);②无心瓣膜病史,心脏超声排除风湿性二尖瓣狭窄;③入选前 2 年内无脑缺血、充血性心力衰竭和血栓栓塞史。

3. 诊断标准:缺血性卒中为突发的局灶性神经系统功能缺陷,持续超过 24h 并以 CT 证实,全身性栓塞诊断标准为无梗死病史的患者发生急性动脉栓塞所致的血流灌注不足的证据。

4. 药物治疗:入选后经审核将愿意并能承受长期华法令治疗的患者编入第 1 组,随机口服以下任一种:华法令 (剂量为使凝血酶原时间较标准延长 2.0~3.5 倍),阿司匹林 (双盲,325mg/d)或者安慰剂;其余患者编入第 2 组,随机口服阿司匹林 325mg/d 或安慰剂。

5. 观察与随访:主要事件为缺血性卒中或全身性栓塞;次要事件为:死亡、MI 不稳定型心绞痛。其它还有药物的合并症 (尤其是出血事件)。平均随访 1.13 年。

6. 统计学分析:所有的分析均基于意图处理方法,两组患者基本状况比较用 χ^2 检验。

结 果

1. 口服安慰剂组患者 (第 1 组加第 2 组)主要事件发生率为每年为 6.3%,抗凝治疗组 (即口服阿司匹林或华法令者)明显低于对照组 ($P < 0.00005$)。发生率分别为每年 1.6%和 8.3%,风险度下降 81%。

2. 服用阿司匹林患者 (第 1 组加第 2 组)主要事件发生率为每年 3.2%,安慰剂组为 6.3% ($P = 0.014$),风险度下降 49%。

3. 年龄大于 75 岁患者 60 例,口服阿司匹林事件发生率为每年 2.2%,对照组为每年 6.2% ($P = 0.0042$),风险度下降 65%。

4. 华法令治疗组,需要住院治疗的出血事件发生率为每年 1.7%,脑出血为每年 0.4%;阿司匹林组分别为每年 0.9%和 0.2%;对照组为每年 1.2%和 0.2%。

讨 论

华法令和阿司匹林均是抗凝剂,在心脑血管缺血性疾病中广泛应用。华法令为香豆素类口服抗凝血药,化学结构与维生素 K 相似,其抗凝血作用的机制是竞争性拮抗维生素 K 的作用,阿司匹林是通过抑制血小板的环氧化酶,减少前列腺素的生成而具有抑制血小板聚集的作用,二者均有引起自发性出血的不良反应,应严密观察。非风湿性心瓣膜病所致的心房颤动伴有较高的缺血性卒中危险性,病因可能为多因素的,不过心源性栓塞是主要的。心房颤动诱发左房血栓形成,后者可造成栓塞,华法令和阿司匹林应用于非风湿性心房颤动患者,对缺血性卒中和全身性血栓栓塞一级预防的疗效优于安慰剂对照组。华法令较之阿司匹林预防心房颤动患者发生缺血性卒中中更为有效,但脑卒中发生率的降低幅度很小。小于 75 岁无危险因素的患者单用阿司匹林,脑卒中发生率很低。大于 75 岁的患者则不论应用何种药物,其脑卒中 (缺血性和出血性)发生率较为恒定。

参考文献

1 黄峻,王文,主编.心脑血管疾病大型临床实验.江苏:江苏科学技术出版社,1997.615~627.

(收稿日期:2005—06—10)

临床用药中常见的药物相互作用

邵焕芬
300480 天津市汉沽医院药剂科

因为治疗需要,临床药物在使用中常几种联合应用。因此,几种药常因相互之间作用可出现药效加强、副作用减轻,也可出现药效减弱或毒副作用加重,在实际应用中出现的有益相互作用对比所出现的不良相互作用仅占很少比例,所以,临床药物联用时要重点预防由于相互作用引起的不良反应。

有益的相互作用

有些药物联合应用疗效上相辅相承,不良反应可相互克服。例如给心绞痛患者用硝酸甘油时合用心得安,由于两药均可降低心肌耗氧,可发挥协同作用,同时又相互克服缺点,如心得安可阻断硝酸甘油引起的反射性心率加快,同时硝酸甘油减少回心血量、减轻心脏负荷,可纠正心得安对心室容积增加的作用。

阿托品和解磷定联用时的相互有益作用与上述两种药物类似。在抢救有机磷中毒时,阿托品可以迅速解除 M 样中毒症状,而解磷定可以使胆碱酯酶复活,从而解除阿托品不能对抗的 N_2 受体引起的肌颤。

还有一些有益的相互作用临床应用也比较广泛,例如磺胺药与 TMP 合用, TMP 可增强磺胺的作用。棒酸 (克拉维酸)能抑制 β -内酰胺酶,与 β -内酰胺类抗生素联合应用起协同作用,可以使阿莫西林增效 130 倍,使头孢菌素增效 2~8 倍。

不良的相互作用

大多数的药物联合应用都会有不良相互作用产生,有的影响药物的作用强度,有的可能对人体产生伤害。

1. 使药效减弱的药物相互作用:①在应用奥硝唑氯化钠液时若同时应用了苯巴比妥或苯妥英钠,会因为苯巴比妥和苯妥英钠具有的酶促作用,使奥硝唑代谢加强,血药浓度降低,疗效降低。②口服双歧杆菌活菌制剂时,其若与抗生素合用可使其疗效减弱。此外双歧杆菌活菌制剂也不能与药用碳合用,药用碳会对前者产生吸附,使双歧杆菌活菌制剂药效减弱。③在口服赖氨酸肌醇 $V_{iB_{12}}$ 时应避免应用氯霉素,因为氯霉素对骨髓的抑制作用会抵消 $V_{iB_{12}}$ 的造血作用。

2. 使毒副作用增加的药物相互作用:①在使用非甾体抗炎

药时不能同时使用一种以上其他同类药物,因为它们会产生协同作用而增加胃、肠溃疡及出血的可能性。应用氨基糖甙类药物时也不可速尿合用,因为两者都有耳毒性,合用会损害听力。②酶抑或酶促进作用也会引起毒副作用。例如西咪替丁与茶碱合用,由于西咪替丁的酶抑作用使茶碱代谢受阻,茶碱血药浓度升高,会出现不良反应甚至可致死死亡。环磷酰胺与苯巴比妥合用,由于后者的酶促进作用使环磷酰胺在短时间内生成较多的活性物——醛磷酰胺而出现骨髓抑制加强。③有的药物相互作用而产生的毒副作用是由于其在体内相互竞争血浆蛋白或竞争排泄。一些血浆蛋白结合率很高的药物如甲苯磺丁脲其蛋白结合率为 95%,若某种药物与之竞争血浆蛋白,使其蛋

白结合率下降为 90%,则其游离体就会由 5%增加到 10%,其毒副作用就会加强。丙磺舒与青霉素都是经肾小球分泌而进入原尿排泄,两者合用由于竞争排泄会使血药浓度升高,易产生副作用,应避免合用。

总之,临床上药物联用不可避免,这就要求医务人员对药物相互作用要充分了解,明白其相互之间的物理性质、化学性质及在特殊生理条件下的反应,还要充分掌握各药的作用、副作用及毒性。应结合病人病情谨慎合理地使用药品,使其发挥优点,促进病人康复。

(收稿日期:2005—07—20)

贝复剂在化疗引起的口腔溃疡中的应用

方玉芹
210048 江苏省南京市江北人民医院消化肿瘤科

化疗后引起的口腔溃疡是化疗病人常见的并发症,由于口腔溃疡引起疼痛,影响进食使治疗不能顺利完成,多见于 5—Fu 治疗的患者,且静脉连续滴注 96h 以上,则粘膜炎成为主要毒性反应^[1],我科从 2003 年 5 月以来已发生口腔溃疡病人 60 例,在常规治疗的基础上采用贝复剂局部喷涂治疗,取得满意的疗效,现将治疗情况及护理介绍如下:

资料和方法

1. 临床资料:本组 60 例,其中男 22 例,女 38 例,年龄 38~76 岁,平均年龄 57 岁。其中胃癌 32 例,大肠癌 18 例,胰腺癌 4 例,其他 2 例。口腔溃疡最大面积 0.5cm×0.8cm,最小面积 0.2cm×0.2cm;溃疡数最少 4 处,最多 10 处,均为使用微量泵,持续 24h 静脉泵入 5—Fu 疗程 21d 者。口腔溃疡一般于化疗后 6~7d 出现,两组病人健康状况、体重相似,溃疡数目及部位相近具有可比性。化疗过程中产生口腔溃疡,接受贝复剂治疗的为贝复剂组,常规治疗的为对照组。两组患者病情资料见表 1。

表 1 两组患者病情资料

组别	例数	性别		年龄	溃疡个数			
		男	女		舌尖	舌根	下唇	牙龈
贝复剂组	30	11	19	57	100	42	60	18
对照组	30	11	19	57	88	34	62	16

2. 治疗方法:两组患者均给高蛋白、高热量、高维生素、无刺激性流质饮食,对照组接受常规治疗给生理盐水清洗口腔 3~5 次/d 保持口腔清洁,疼痛严重时可用 0.5%普鲁卡因液含漱治疗 1 周。贝复剂组在常规治疗的同时加用贝复剂治疗 1 周,其方法为:①用生理盐水清洗口腔,拭净溃疡表面坏死、脱落的粘膜分泌物,将贝复剂直接喷于患处或在患处覆盖适当大小的消毒纱布,用药液均匀喷湿纱布(以药液不溢为准)。②对感染性创面可酌情联合局部或全身使用抗生素。

结 果

1. 疗效标准:治疗 1 周后评价疗效,治愈:口腔溃疡完全消

失;显效:口腔溃疡数目及面积减少一半;无效:口腔溃疡数目及面积减少低于一半,或溃疡无变化及数目增多,感染面积扩大。

2. 两组疗效观察、比较见表 2。

表 2 贝复剂组与对照组疗效比较

组别	例数	治愈	显效	无效	总有效率(%)	P
贝复剂组	30	26	4	0	100	
对照组	30	6	8	16	46.67	<0.05

讨 论

化疗引起的口腔溃疡是由于化疗药物损伤口腔粘膜细胞,使口腔和口腔软组织炎症形成溃疡和感染^[2]。而贝复剂是一种多功能细胞生长因子(b-bFGF),对来源于中胚层和神经外胚层的多种组织细胞(如上皮细胞、真皮细胞、纤维细胞、血管内皮细胞、神经细胞等)具有促进分化和均衡生长调节等作用;在组织分化、功能维持及损伤修复等方面具有显著功效,药理表明 b-bFGF 能促进细胞分裂和分化,促进组织损伤的修复,加速创面的愈合,贝复剂组患者的疗效表明了这一点。同时,使用期间要做好健康宣教,如加强营养,给高蛋白、高热量、高维生素,流质饮食,不吃对口腔粘膜有刺激性的食物,如:过热、过酸、咸及粗糙等食物,不吸烟、不喝酒,做好口腔护理,多饮水保持口腔清洁湿润,定期监测血常规,对有明显骨髓抑制的患者,给粒细胞集落刺激因子尽快使骨髓功能恢复。化疗引起的口腔溃疡通过应用贝复剂,病人疼痛减轻、生活质量提高,使化疗顺利进行,实验表明贝复剂是目前治疗化疗引起的口腔溃疡效果满意的一种药物。

参考文献

1 孙燕.内科肿瘤学.人民卫生出版社,2001.388.
2 周际昌.实用肿瘤内科学.人民卫生出版社,2000.28.

(收稿日期:2005—07—14)